

LAS NEUROSIS Y EL PROBLEMA DE LA SIMULACIÓN

Lección inaugural de la cátedra de clínica de las enfermedades
del sistema nervioso · Apartados VI y VII

Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière

Tomo III · París, Progrès Médical / Delahaye et Lecrosnier, 1887

Autor: Jean-Martin Charcot (1825-1893).

Obra: *Leçons sur les maladies du système nerveux*, tomo III, Lección inaugural. Pronunciada al asumir la cátedra de clínica de las enfermedades del sistema nervioso, creada para él por la Facultad de Medicina de París.

Recorte: apartados VI y VII, donde Charcot expone el problema de los estados mórbidos sin lesión y responde a la acusación de simulación. Se omiten los apartados I a V, dedicados a la creación de la cátedra, los medios de estudio del servicio y las localizaciones cerebrales.

Traducción: Cátedra de Psicopatología I, UFLO Online, 2026, desde el original francés, que es de dominio público.

Establecimiento del texto: ejemplar digitalizado de la edición original (Internet Archive, id. *oeuvrescompltesd03char*).

Advertencia: este **no** es el texto que el programa cita por la compilación de J. Saurí.

Sumario de la lección [del original]

*Creación de la cátedra de clínica de las enfermedades del sistema nervioso. — Medios de estudio: hospicio-hospital, consulta externa, laboratorios. — Legitimidad de la especialización de la enseñanza de la patología nerviosa. — Intervención de las ciencias anatómicas y fisiológicas en la patología; condiciones en que debe tener lugar. — Método nosológico. — Método anatomoclínico. — **Las neurosis reconocen las leyes fisiológicas comunes.** — **Dificultades de su estudio.** — **Simulación.***

VI. [Los estados sin lesión]

Se comprende, por lo que precede, la importancia que deberemos acordar en nuestros estudios a la investigación anatomopatológica. Pero no ignoran ustedes, señores, que existe todavía, al día de hoy, un gran número de estados mórbidos que tienen evidentemente por sede el sistema nervioso y que **no dejan sobre el cadáver ninguna traza material apreciable**. La epilepsia, la histeria aun la más inveterada, la corea y muchos otros estados mórbidos que sería largo enumerar se nos ofrecen como otras tantas *esfinges que desafían a la anatomía más penetrante*.

Esos compuestos sintomáticos privados de sustrato anatómico no se presentan al espíritu del médico con esa apariencia de solidez, de objetividad, que pertenece a las afecciones ligadas en adelante a una lesión orgánica apreciable.

Algunos no ven incluso en varias de esas afecciones más que un conjunto de fenómenos bizarros, incoherentes, inaccesibles al análisis, y que acaso valdría más relegar a la categoría de lo incognoscible. Es la histeria la que está sobre todo apuntada por esa suerte de proscripción.

Pero un decreto, venga de donde venga, jamás bastará para hacerla borrar del cuadro nosológico. Nos hará falta, pues, tomarla tal como es y no dejarnos rebotar por las dificultades que presenta su estudio.

Por lo demás, señores, solo una observación superficial ha podido conducir a la opinión que acabo de señalar; un estudio más atento nos hace ver las cosas bajo un aspecto muy distinto. Y un gran mérito de Briquet es haber establecido, en su bello libro, de manera irrefragable, que **la histeria reconoce también, al mismo título que los otros estados mórbidos, reglas y leyes** que una observación atenta y suficientemente multiplicada permitirá siempre desprender.

Permítanme, por no citar más que un ejemplo, recordarles la descripción del gran ataque histérico, hoy reducida a una fórmula muy simple. Cuatro períodos se suceden en el ataque completo con la regularidad de un mecanismo: 1.º epileptoide; 2.º grandes movimientos, contradictorios, ilógicos; 3.º actitudes pasionales, lógicas; 4.º delirio terminal. Pero el ataque puede ser incompleto: cada uno de los períodos puede mostrarse aisladamente, o bien uno o dos de ellos faltarán. Se comprende cuántas variedades podrán resultar de esas combinaciones; pero siempre le será fácil, a quien posea la fórmula, reducirlas todas al tipo fundamental.

Todo esto interesa en el más alto grado al clínico, que debe aprender a orientarse en medio de ese dedalo en apariencia inextricable. Pero lo que quiero señalar aquí es que en el ataque —y podría decir otro tanto de muchos otros episodios de la histeria— **nada queda librado al azar**; que todo ocurre allí, por el contrario, según reglas, siempre las mismas, comunes a la práctica de la ciudad y a la del hospital, válidas para todos los países, para todos los tiempos, para todas las razas; universales, por consiguiente.

Hay otro gran hecho en la historia de las neurosis en general, y de la histeria en particular, que muestra bien que esas afecciones no forman en la patología una clase aparte, gobernada por leyes fisiológicas distintas de las comunes. Es que su sintomatología se aproxima siempre, y a menudo muy estrechamente, a la que se liga a las enfermedades con lesiones materiales. Y la semejanza es a veces tan llamativa que vuelve el diagnóstico de los más arduos. Se ha designado alguna vez con el nombre de *neuromimesis* esa propiedad que tienen las afecciones *sine materia* de simular las enfermedades orgánicas.

Entre la hemianestesia vulgar de las histéricas y la que depende de una lesión en foco la analogía es llamativa: en el fondo es el mismo síndrome. La misma semejanza entre la paraplejía espasmódica de las histéricas y la que depende de una lesión orgánica espinal. Ahora bien, esa semejanza, que a veces desespera al clínico, debe servir de enseñanza al patólogo, que detrás del síndrome común entrevé una analogía de sede anatómica. Y esto nos conduce a reconocer que **los principios que rigen el conjunto de la patología son aplicables a las neurosis.**

VII. [La simulación]

Ya que estoy hablándoles de las dificultades que el clínico encuentra en el estudio de las neurosis y de los medios de que dispone para superar esos obstáculos, hay todavía un punto que quisiera, antes de terminar, señalar a su atención. Se trata de la **simulación**: ya no de esa imitación de una enfermedad por otra de la que hablábamos hace un momento, sino de la simulación intencional, deliberada, en la cual los enfermos exageran síntomas reales o crean enteramente una sintomatología imaginaria.

Todos saben, en efecto, que la necesidad de mentir —unas veces sin interés, por una suerte de culto del arte por el arte; otras con vistas a causar sensación, a excitar la piedad— es cosa vulgar, en particular en la histeria. He aquí un elemento que encontraremos a cada paso en la clínica de esta

neurosis y que arroja, no hay que disimulárselo, un día de desfavor sobre los estudios que se le ligan.

Pero hoy, señores, cuando la historia de la histeria ha sido tantas veces rehecha y escudriñada en todos los sentidos, ¿es verdaderamente tan difícil como algunos parecen creer discernir la sintomatología real de la sintomatología imaginaria? De ningún modo, señores.

[Sigue la demostración con la catalepsia hipnótica. Charcot registra con un tambor de reacción los movimientos del brazo extendido y con un neumógrafo la respiración, en una cataléptica y en un hombre que intenta sostener la misma postura.]

En resumen, como ven, **la cataléptica no conoce la fatiga**: el músculo cede, pero sin esfuerzo, sin intervención voluntaria. El simulador, por el contrario, sometido a la doble prueba, se encuentra traicionado por los dos lados a la vez: primero, por el trazado del miembro, que acusa la fatiga muscular; segundo, por el trazado de la respiración, que traduce el esfuerzo destinado a enmascarar sus efectos.

*Inútil insistir. Otros cien ejemplos podrían invocarse que mostrarían que **la simulación, de la que tanto se habla cuando se trata de la histeria o de afecciones conexas, no es, en definitiva y en el estado actual de nuestros conocimientos, más que un espantapájaros ante el cual solo se detendrán los tímidos o los novicios.***

En adelante le corresponde al médico verdaderamente instruido en estas materias descubrir la impostura dondequiera que se produzca, y separar si hace falta, de los síntomas reales que forman parte esencial de la enfermedad, los síntomas simulados que el artificio de los enfermos quisiera sobreañadirles. Abordaremos, pues, con prudencia sin duda, pero también con confianza, el estudio de esas afecciones temidas, penetrados como estamos de la seguridad de los métodos de observación que están en nuestras manos.

El tiempo apremia y debo concluir. Sería feliz si hubiera logrado, en el esbozo que precede, hacerles entrever el ideal hacia el cual tenderán todos nuestros esfuerzos. En la solución de los problemas que se nos impondrán, todas las ramas, todas las disciplinas de la ciencia biológica deberán, prestándose un apoyo mutuo y controlándose una a otra, marchar al mismo paso hacia el mismo fin. Pero sostengo que, en ese concierto, **el papel preponderante, la jurisdicción suprema, deberá pertenecer siempre a la observación clínica.**

[Fin del recorte.]

Nota de la traducción

Traducida del francés por la cátedra, desde el original, que es de dominio público. Los títulos de los dos apartados van entre corchetes: el original solo los numera. Los cortes y las aclaraciones de la cátedra van también entre corchetes. Las cursivas y los destacados reproducen los énfasis del original o señalan las formulaciones sobre las que trabaja la clase.

Establecido sobre el ejemplar digitalizado de la edición original disponible en Internet Archive (id. *oeuvrescompltesd03char*), donde puede controlarse el francés de cualquier pasaje.